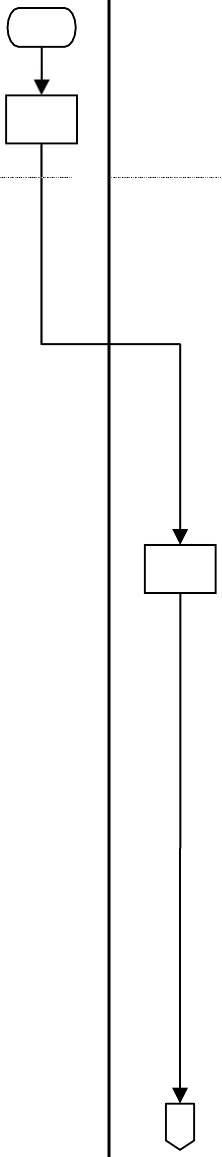
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

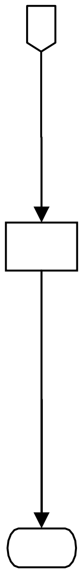
Jl. Cikapayang No. 5 Bandung – Jawa Barat
Telp. 022-4219305

Nomor SOP	OT.02.02/1/030/2020
Tanggal Pembuatan	11 September 2015
Tanggal Revisi	2 Januari 2020 (Rev.01)
Tanggal Efektif	5 Januari 2020
Disahkan oleh	Kepala Kantor KKP Kelas II Bandung KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Rahmat Subakti, SKM,MHM NIP. 196507131988031002
Judul SOP	Rujukan dan Tata Laksana

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. International Health Regulation (IHR) tahun 2005 ; 2. UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3273) ; 3. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447) 5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503) 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (H5N1) (Avian Influenza) 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 940/MENKES/PER/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa. 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014	Fungsional Epidemiologi/ Sanitarian/ Entomolog/ Dokter/ Perawat

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pemantauan K3JH 2. SOP Penemuan Kasus 3. SOP Jejaring Informasi	- Masker N95 - Oksigen - Peralatan terkait lainnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini memberikan panduan dalam melakukan rujukan dan tata laksana.	- Surat Rujukan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pasien	Petugas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pasien berobat.				1 jam		Dengan gejala pneumonia berat, riwayat pulang dari Arab Saudi kurang dari 14 hari.
2	Petugas Kesehatan, melakukan upaya rujukan.				1 jam	Surat Rujukan	Petugas kesehatan adalah Dokter Puskesmas, atau Dokter praktek swasta. Upaya rujukan yang harus dilakukan (Puskesmas): 1. Memasangkan masker bedah terhadap jamaah haji tersebut. 2. Petugas memakai masker N95 3. Jamaah diberikan oksigen dan pengobatan supportif lainnya 4. Jamaah dirujuk menggunakan ambulans evakuasi penyakit menular. 5. Apabila tidak memungkinkan menggunakan ambulans tersebut, maka dapat digunakan ambulans yang tersedia dengan catatan ada partisi antara sopir dan pasien, tidak menggunakan fasilitas AC yang ada dan jendela dibuka lebar. 6. Petugas menghubungi Rumah Sakit Rujukan untuk menyiapkan fasilitas ruang isolasi. Untuk Dokter Swasta/ Rumah Sakit Non Rujukan: a) Apabila ditemukan jamaah haji dengan pneumonia berat, dilakukan upaya rujukan sebagai berikut : 1. Memakaikan masker bedah kepada jamaah haji 2. Dokter menggunakan masker N95 3. Jamaah haji diberikan oksigen dan pengobatan supportif lainnya 4. Dokter menghubungi dinas kesehatan untuk dilakukan evakuasi rujukan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pasien	Petugas Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Petugas kesehatan melakukan tindakan setelah merujuk pasien sebagai berikut: Puskesmas/ Rumah Sakit Non Rujukan: 1. Petugas melakukan personal hygiene maksimal (mandi dan memakai pakaian yang baru) di rumah sakit rujukan. 2. Pakaian yang digunakan petugas pada saat merujuk, tidak boleh dibawa pulang, dimusnahkan di rumah sakit rujukan. 3. Melakukan desinfeksi terhadap ambulan Dokter Swasta: Setelah proses rujukan selesai, dokter melakukan personal hygiene maksimal (mandi dan memakai pakaian baru, pakaian lama dimusnahkan) kemudian ruang prakteknya bila dimungkinkan dilakukan upaya desinfeksi.				1 jam		